Die Videoreihe 2.0

Strategiepapier: Struktur, Evidenzstufen, Disclaimer, Themen

Gesundheits-Faktenchecks auf YouTube · Stand 02.11.2026 · Grundlage: fünf Drehbücher, zwei Recherchen mit Websuche, Stichproben nachgeprüft

Kennzeichnung: **Sicher** aus Primärquelle oder Gesetzestext, nachgeprüft · **Wahrscheinlich** aus seriöser Sekundärquelle oder abgeleitet · **Vermutung** unsere Einschätzung. Empfehlungen sind immer Vermutungen. Sie sind Urteile und keine Fakten, deshalb fehlt dort die Marke. Rechtliches ist keine Rechtsberatung, sondern Recherche.

1 · Das Wichtigste vorweg

> **Die unbequeme Wahrheit zuerst:** Der Maßstab „im Gespräch und nicht widerlegt“ würde die Reihe genau zu dem machen, was sie entlarven will. Fast jeder Hype ist „nicht widerlegt“. Das liegt aber daran, dass ihn niemand geprüft hat, nicht daran, dass er stimmt. Innovativ wird die Reihe durch **neue Evidenz** und durch eine ehrliche Stufe für junge Befunde. Ungeprüfte Behauptungen machen sie nicht innovativ.

1. **Hook in den ersten 8 Sekunden.** Alle fünf Videos beginnen mit einer Feststellung. Die erste spannende Frage kommt frühestens nach etwa 10 s. Neu ist deshalb ein Satz mit der stärksten Behauptung und einem offenen Versprechen. Danach kommen erst die Kacheln.
2. **Jedes Video bringt mindestens einen „Neu“-Punkt.** Das ist eine Studie, Meta-Analyse, Leitlinie oder Behördenbewertung aus den letzten 24 Monaten, die das Bild verändert. Dazu kommt die vierte Ampelstufe **Frühe Hinweise** (blau) für vielversprechende, aber junge Befunde.
3. **Die Evidenz steckt im Verb, Zahlen stehen als „N von 100“.** Die Stufen lauten „senkt“, „senkt wahrscheinlich“, „senkt möglicherweise“ und „ist unklar“. Nutzen und Schaden bekommen dieselbe Bezugsgröße, die Studienart steht im selben Satz.
4. **Der Hinweis kommt dreistufig statt als Werbeformel.** Im Einstieg wird eine Zeile 5 s lang eingeblendet. Wo ein Risiko besteht, steht ein konkreter Satz. Am Schluss folgt ein eigener Satz mit „Arzt oder Ärztin“. „Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ übernehmen wir nicht: Das ist der Pflichttext für Arzneimittelwerbung, und er lautet inzwischen anders.
5. **Themen werden nach Scorecard gewählt.** Die Kriterien sind Interesse, Hype-Diskrepanz, neue Evidenz, Gefahr und Prüfbarkeit in 6 Minuten. Die nächsten fünf Themen sind Mikroplastik im Gehirn, Kreatin fürs Gehirn, Vitamin D, Kollagen und Magnesium-Threonat (Abschnitt 8).

> **Rückfrage mit Gewicht:** Hat der Kanal ein Impressum mit einem Verantwortlichen nach § 18 Abs. 2 MStV? Wenn nicht, ist das der einzige Punkt in diesem Papier, der echtes Bußgeldrisiko trägt, nämlich bis zu 50.000 € **Sicher** (Normtext). Alles andere ist Qualität, nicht Pflicht.

2 · Bestandsaufnahme der fünf Videos

Merkmal	Befund	Bewertung
Aufbau	Alle gleich: sechs Kacheln, sechs Szenen, „Was bleibt also?“ mit drei Punkten, „Die Quellen stehen in der Beschreibung.“ Länge 5:10–6:04.	Gute, wiedererkennbare Marke. Aber: YouTube schließt „templated storylines“ mit KI-Elementen von der Monetarisierung aus. Gemeint ist Massenware, unsere Videos fallen nicht darunter **Wahrscheinlich**. Trotzdem sollten Ablauf und Wortlaut leicht variieren.
Einstieg	Feststellung („Magnesium gehört zu den beliebtesten …“), dann eine Aufzählung der sechs Fragen.	Schwächster Teil. YouTube misst die Bindung nach 30 s als eigene Kennzahl „Intro“ **Sicher**. Eine Aufzählung zu Beginn ist ein Inhaltsverzeichnis, kein Grund dranzubleiben.
Marker	Tomatenmark hat 13 von 20 Punkten gelb, Stress 8, Magnesium 2 hat 7.	Viel Gelb heißt für Zuschauer „weiß man nicht“. Meist liegt das daran, dass die Behauptung zu grob geschnitten ist. Wird sie in zwei Teilaussagen geteilt, ergibt das oft ein Grün und ein Rot.
Richtung	Jedes Video verteidigt den Status quo gegen Hype.	Das ist richtig, aber vorhersehbar. Kein Video bringt eine Erkenntnis, die neuer ist als die geprüfte Behauptung.
Hinweis	„Ersetzt keinen ärztlichen Rat“ wird nur bei Guanfacin gesprochen, sonst steht er in Fußzeile und Beschreibung. Die konkreten Sicherheitssätze sind gut („nie plötzlich absetzen“, „wer schwache Nieren hat …“).	Die konkreten Sätze machen mehr als jede Floskel. Sie werden zur Regel.
Schluss	Er endet mit dem Verweis auf die Quellen. Es gibt keinen Ausblick und keine Frage an die Zuschauer.	Damit wird eine Chance auf Kommentare und Themenvorschläge verschenkt.

Wo wir im Markt stehen

Die zehn meistgesehenen deutschen Gesundheits-Erklärvideos seit Ende 2024 haben eine Medianlänge von 17:50. Das kürzeste erfolgreiche Video ist 5:17 lang (625.000 Aufrufe). Fünf der zehn stammen von öffentlich-rechtlichen Sendern (MAITHINK X, Quarks, STRG_F), drei von Arzt-Creatorn **Sicher** (Stichprobe per yt-dlp, 02.11.2026). In Titeln dominiert das **Urteils-Versprechen**: „wissenschaftlich geprüft“, „Die unbequeme Wahrheit über …“, „Was geht und was nicht geht“.

Folgerung: Die Reihe kann MAITHINK X nicht mit 6 Minuten, synthetischer Stimme und ohne Gesicht schlagen. Sie kann sich aber daneben stellen: **das schnellste ehrliche Urteil**, sichtbar als Ampel, mit dem, was neu ist. Die Länge ist kein Nachteil, solange das Thema in 6 Minuten vollständig prüfbar ist. Einen Beleg, dass YouTube kurze Videos bestraft, gibt es nicht **Wahrscheinlich**. Mid-Roll-Werbung gibt es erst ab 8 Minuten **Sicher**. Das ist eine bewusste Entscheidung, die bei Monetarisierungsplänen neu zu prüfen ist.

3 · Strukturvorlage v2, Sekunde für Sekunde

Ziel ≈ 6:00 bei ≈ 720 Wörtern und 2,1 Wörtern/s (Christian, 2,2–2,3 bei den anderen Stimmen).

Zeit	Teil	Inhalt	Bild
0:00–0:08	**Hook** (≈ 18 Wörter)	Die stärkste Behauptung mit offenem Versprechen. Formel: *Behauptung + „Eine davon stimmt, eine ist sogar gefährlich.“* oder *„Eine neue Studie sagt X. Fachleute halten dagegen.“* Keine Begrüßung, kein Kanalname.	Ein großes Motiv im Vollbild, noch keine Kacheln.
0:08–0:25	**Kacheln**	Sechs Fragen, aber als Fragen formuliert statt als Aufzählung. Die Legende wird nur eingeblendet. In der Fußzeile steht 5 s lang der Hinweis (Abschnitt 5).	Kacheln wie bisher, Aufleuchten über Zeitmarken.
0:25–5:15	**Sechs Szenen** à ≈ 45 s / 95 Wörter	Ablauf je Szene: **Behauptung** („Oft heißt es …“) → **Prüfung** (Studienart und Größe im Satz, „N von 100“) → **Urteil** (Marker, Evidenz im Verb) → **Grenze** (ein Satz: „nur Männer“, „nur 6 Wochen“, „vom Hersteller bezahlt“) → **Tipp** (du). Mindestens eine Szene ist die **„Neu“-Szene**. Szene 2 oder 3 enthält eine **Wende**, also einen Punkt, der überrascht, damit die Bindungskurve in der Mitte nicht absackt.	Ein eigenes Bild je Szene, Marker unten.
5:15–5:45	**Fazit**	Drei Punkte wie bisher, aber der dritte ist der Handlungstipp mit der größten Wirkung. „Was bleibt also?“ darf variieren.	Drei Marker im Überblick.
5:45–6:00	**Schluss**	Erst der eigene Hinweissatz (Abschnitt 6), dann ein **Ausblick oder eine Frage**: *„Welche Behauptung sollen wir als Nächstes prüfen? Schreib sie in die Kommentare.“* Bei frühen Hinweisen zusätzlich: *„In einem Jahr schauen wir wieder hin.“* „Quellen in der Beschreibung“ wird nur eingeblendet.	Ruhiges Schlussbild.

Hook-Beispiele für die vorhandenen Videos (nur zur Anschauung, Inhalt vor Verwendung gegen das Drehbuch prüfen)

- **Guanfacin:** *„Sanfter als Ritalin, wirkt nach ein paar Tagen, hilft sogar gegen Angst. Drei Versprechen zu einem ADHS-Medikament, und nicht alle halten.“*
- **Tomatenmark:** *„Ein Löffel Tomatenmark soll Gehirn und Herz schützen. Gemessen hat man vor allem etwas anderes.“*
- **Magnesium:** *„Der Bluttest beim Arzt sagt fast nichts über deinen Magnesiumspeicher. Und das ist nicht der einzige Irrtum.“*

Grenze des Hooks: zuspitzen ja, täuschen nein. YouTube verbietet „bewusst täuschende“ Titel und Thumbnails **Sicher**. Die Clickbait-Forschung zeigt zwar, dass Übertreibung Aufrufe bringt, aber ohne Beleg für Vertrauen. Der Hook muss im Video eingelöst werden.

4 · Evidenzstufen: vier Farben, klare Sprache

Belegt **Frühe Hinweise** **Teilweise** **Nicht haltbar**

Stufe	Wann	Sprechformel
Belegt	Mehrere gute Studien am Menschen oder Leitlinie bzw. Behörde. GRADE „hoch“ oder „moderat“.	*„senkt“, „senkt wahrscheinlich“*
Frühe Hinweise (neu)	Es müssen **alle vier** Bedingungen gelten: (1) mindestens eine randomisierte Studie am Menschen mit relevantem Endpunkt, (2) die Gewissheit ist niedrig (klein, kurz, nicht wiederholt, Surrogat oder nur Hersteller), (3) kein Sicherheitssignal bei üblicher Dosis, (4) ein plausibler Mechanismus. Bei reinen Herstellerstudien muss „herstellerfinanziert“ im Markertext stehen.	*„möglicherweise ja, bisher zeigt es aber nur eine Studie mit fünfzehn Personen“*
Teilweise	Stimmt nur eingeschränkt (Gruppe, Dosis, Größe) oder die Studien widersprechen sich.	*„ein bisschen“, „nur bei …“*
Nicht haltbar	Widerlegt *oder* nie untersucht. Was davon zutrifft, sagt der Text: *„widerlegt“* bzw. *„hat niemand geprüft“*.	*„stimmt nicht“, „dafür gibt es keinen Beleg“*

Warum Blau und nicht Hellgrün: Blau ist eine andere Aussage, keine Abstufung. Hellgrün würde als „fast belegt“ gelesen, Gelbgrün als „gemischt“ **Vermutung**. Vorbild ist die Skala von Medizin-transparent (Cochrane Österreich). Sie trennt Richtung („ja/nein“), Größe („ein bisschen“) und Vertrauen („möglicherweise/wahrscheinlich“) **Sicher**.

> **Gefahr bekommt ein eigenes Zeichen.** Ist eine Behauptung nicht nur falsch, sondern schädlich (Megadosen, Medikamente absetzen, Kinder, Schwangerschaft), steht neben dem roten Marker ein ⚠ und die Szene endet mit einem konkreten Sicherheitssatz. So bleibt „falsch“ von „gefährlich“ unterscheidbar. Rot allein heißt beides.

Darstellungsregeln mit Beleg

1. **Absolute Zahlen mit fester Bezugsgröße.** *„Von 100 mit Placebo hatten 8 …, mit dem Mittel 6.“* Relative Risiken allein werden als größer wahrgenommen und überzeugen mehr, sie werden aber nicht besser verstanden (Cochrane-Review Akl 2011) **Sicher**. Das passt zur Kanalregel „Brüche statt Prozent“.
2. **Gleiche Bezugsgröße für Nutzen und Schaden** (Harding-Zentrum, Methodenpapier 2021) **Sicher**.
3. **„1 von X“ vermeiden.** „1 von 200“ wirkt alarmierender als „5 von 1000“ (Pighin 2011) **Sicher**.
4. **Evidenz im Verb:** „senkt“, „senkt wahrscheinlich“, „senkt möglicherweise“, „unklar“ (GRADE-Sprachregel, Santesso 2020) **Sicher**. Farbe und Verb müssen übereinstimmen.
5. **Studienart im selben Satz:** „bei Mäusen“, „fünfzehn Personen“, „noch nicht begutachtet“, „vom Hersteller bezahlt“.
6. **Surrogat benennen:** Telomere oder Blutwerte sind keine Krankheit. Dazu gehört der Satz *„Ob man dadurch länger lebt, hat niemand gemessen.“*
7. **Höchstens eine Zahl pro Satz** und 2–4 Endpunkte pro Thema (Kanalregel, Harding).

5 · Innovation ohne Unsinn

Dein Wunsch: neue Ansätze statt altmodischer Information, aber kein Unsinn. **Meine Gegenposition:** „Nicht widerlegt“ ist kein Qualitätsmerkmal. Ein Beispiel: Für Magnesium-L-Threonat gibt es drei randomisierte Studien, alle vom Hersteller oder Vertrieb bezahlt. Eine unabhängige Studie haben die Agenten nicht gefunden **Wahrscheinlich**. Mit „nicht widerlegt“ als Maßstab stünde Threonat im Video als Innovation. Mit unserem Maßstab steht es als „frühe Hinweise, herstellerfinanziert, objektiver Schlaf ohne Effekt“. Das ist ehrlicher und zugleich die spannendere Geschichte.

Fünf Quellen echter Neuigkeit

Quelle	Warum neu und seriös	Beispiel aus der Recherche
Neue Meta-Analyse oder große Studie	Sie verändert die Gewissheit, nicht nur die Schlagzeile.	Kältebäder: erste Meta-Analyse zu Gesundheit, Entzündungsmarker steigen kurzfristig **Wahrscheinlich**
Leitlinienwechsel	Die stärkste Referenz, oft gegen den Hype.	Endocrine Society 2024: kein Routinetest auf Vitamin D **Sicher** (laut Agent, Primärquelle)
Fachkritik an einer Hype-Studie	„Wissenschaft korrigiert sich“ als Erzählung.	„Löffel Plastik im Gehirn“: Messmethode in Nature Medicine angefochten **Wahrscheinlich**
Trennung nach Finanzierung	Das ist unsere Kernregel und selten öffentlich.	Kollagen: Effekt nur in industriefinanzierten Studien **Wahrscheinlich**
Behördenwarnung	Sie kommt in Supplement-Videos praktisch nie vor.	Ashwagandha: BfR-Warnung 2024, Leberschäden **Wahrscheinlich**

Alle Beispiele stammen aus der Agentenrecherche. Vor einem Video wird jedes wie gewohnt einzeln gegen die Primärquelle geprüft.

Zwei neue Formate

- **„Wiedervorlage“:** Jeder blaue Marker bekommt ein Datum. Nach 12–24 Monaten folgt ein kurzes Update-Video, das zeigt, ob der Befund wiederholt wurde. Das ist ein Versprechen, das kein Hype-Kanal geben kann **Vermutung**.
- **„Was sich geändert hat“:** Ein Video zu einer Aussage, die früher galt und heute nicht mehr gilt (oder umgekehrt). Zum Vergleich: „Darum habe ich meine Meinung geändert“ von DoktorWeigl hatte 690.000 Aufrufe **Sicher** (yt-dlp).

6 · Hinweis und Disclaimer

6.1 Rechtlicher Rahmen

Frage	Antwort
Ist ein Disclaimer Pflicht?	**Nein.** Weder YouTube noch das Gesetz verlangen ihn für redaktionelle Information **Sicher** (YouTube-Hilfe, HWG § 4). Der Pflichttext nach § 4 Abs. 3 HWG gilt nur für *Werbung* für Arzneimittel.
Schützt ein Disclaimer vor Haftung?	Kaum. Urteile zur Wirkung von „ersetzt keinen ärztlichen Rat“ wurden nicht gefunden. Praktiker nennen pauschale Disclaimer „oft nicht mehr als ein Placebo“ **Wahrscheinlich**. Vor Haftung schützt die Sorgfalt: Quellen prüfen, keine Dosierungsanweisung für konkrete Präparate, nie von einer Therapie abraten.
Wann wird ein Video zur Werbung?	Sobald es den Verkauf oder die Verschreibung fördern soll. Nach dem EuGH (Damgaard 2009) kann auch ein unabhängiger Dritter werben **Sicher** (Tenor). Der BGH stellte am 26.03.2026 (I ZR 74/25, Cannabis) auf das Ziel der Botschaft ab. Auch Werbung für eine ganze Wirkstoffgruppe kann darunter fallen **Sicher** (nachgeprüft). **Folge:** keine Marken als Empfehlung, keine Affiliate-Links, keine Rabattcodes. Mit dem ersten Affiliate-Link kippt dasselbe Video in Werbung.
Und bei Rx-Medikamenten?	Publikumswerbung ist verboten (§ 10 HWG) **Sicher**. Sachliche Einordnung mit Nutzen *und* Risiken ist erlaubt **Wahrscheinlich**. Heikel ist ein Aufruf wie „frag deinen Arzt nach X“.
Was ist wirklich Pflicht?	Ein **Impressum** (§ 5 DDG, § 18 MStV), erreichbar in höchstens zwei Klicks. Bei journalistisch-redaktionellem Angebot kommt ein **Verantwortlicher** mit Name und Anschrift dazu (§ 18 Abs. 2 MStV). Außerdem gilt journalistische Sorgfalt (§ 19 MStV). Die Medienanstalten nennen ausdrücklich YouTube-Kanäle und Gesundheitsthemen **Sicher** (Merkblatt).
KI-Stimme kennzeichnen?	Keine Pflicht für nicht-realistische KI-Bilder **Sicher**. Die Stimme klingt realistisch, deshalb ist eine Zeile in der Beschreibung der risikolose Weg **Wahrscheinlich**. Die Stimme **nie als Arzt inszenieren**: KI-Personas als „Gesundheitsexperte“ sind von der Monetarisierung ausgeschlossen **Sicher**.

> **Detail zu deinem Fernsehsatz:** „Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ ist der alte Wortlaut. Der Pflichttext lautet heute *„Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.“* **Sicher** (Gesetzestext nachgeprüft). Beide Fassungen klingen nach Werbespot. Ein Faktencheck, der wie Pharmawerbung endet, untergräbt seine eigene Botschaft.

6.2 Wo und wie lang: drei Stufen

Ort	Form	Wortlaut (Vorschlag)
Einstieg, Fußzeile	Nur eingeblendet, 5 s, nicht gesprochen (würde den Hook bremsen).	*Allgemeine Information, keine ärztliche Beratung · Stand 11/2026*
In der Szene mit Risiko	Gesprochen, ein Satz, konkret. Muster von NDR Visite und MAITHINK X **Sicher**.	*„Setz Guanfacin nie plötzlich ab. Das besprichst du mit deinem Arzt oder deiner Ärztin.“*
Schluss	Gesprochen, ≈ 4 s, ein Satz aus Abschnitt 6.3.	siehe unten
Beschreibung	Fester Block am Ende.	*Dieses Video informiert allgemein und ersetzt keine ärztliche Beratung. Stand der Recherche: [Monat/Jahr]. Unabhängig: keine Werbung, keine Affiliate-Links, keine Sponsoren. Die Sprecherstimme ist synthetisch; Recherche und Text stammen von Menschen. Impressum: [Link]*

6.3 Abschlusssatz: drei Varianten

	Wortlaut	Wirkung
A	*„Das hier ist allgemeine Information. Wenn es um deine Gesundheit oder deine Medikamente geht, sprich mit deinem Arzt oder deiner Ärztin, oder frag in der Apotheke.“*	Vollständig und sachlich, aber 4–5 s lang und ein wenig formelhaft.
B	*„Bevor du etwas änderst, vor allem bei Medikamenten: erst mit Arzt oder Ärztin sprechen.“*	Kurz und als Handlungstipp gebaut, passt zur Reihe. **Empfehlung als Standard.**
C	Themenbezogen: *„Wer Blutverdünner nimmt, klärt Vitamin K vorher mit Arzt oder Ärztin.“*	Am wirksamsten, weil konkret. Sie gehört in die Szene; am Schluss steht dann B.

Ein eigener Wortlaut, der sich wiederholt, wird zur Marke. So ist es bei Quarks und beim IQWiG („kann das Gespräch mit Ärztinnen und Ärzten unterstützen, aber nicht ersetzen“) **Sicher**.

7 · Konkrete Empfehlungen zum Guanfacin-Video

Das sind nur Empfehlungen. Umsetzen tut die Guanfacin-Sitzung.

1. **Hook statt Feststellung:** Mit den drei Versprechen beginnen (Abschnitt 3), dann die Kacheln.
2. **Ein Satz mit leichtem Rechtsrisiko:** *„… frag den Arzt oder die Ärztin gezielt nach den Alternativen; Guanfacin ist eine davon.“* Das ist nahe an „frag nach X“, also an einem Aufruf zu einem Rx-Mittel. Vorschlag: *„… frag den Arzt oder die Ärztin gezielt nach Alternativen zu den Stimulanzien.“* **Vermutung** (geringes Risiko, Formulierung kostet nichts).
3. **Schlusssatz:** „Dieses Video ersetzt keinen ärztlichen Rat.“ durch Variante B ersetzen. Der Absetz-Satz in der Szene bleibt, er ist genau richtig.
4. **Markennamen** nur dort, wo sie zur Einordnung nötig sind („Methylphenidat, bekannt als Ritalin“, ist so in Ordnung). „Intuniv“ steht nur in den Quellen.
5. **Schluss mit Frage:** *„Welches Medikament sollen wir als Nächstes prüfen?“*
6. **Stimme:** Sollte eine andere Stimme gewählt werden, wird der Ton vor dem Rendern neu eingesprochen (≈ 2.300 Zeichen).

8 · Themen-Scorecard und Fahrplan

Je Kriterium gibt es 1–5 Punkte, gewichtet: **Interesse** 25 % (Google Trends, YouTube-Aufrufe), **Hype-Diskrepanz** 25 %, **neue Evidenz** ≤ 24 Monate 20 %, **Gefahr bzw. Nutzen des Tipps** 15 %, **in 6 Minuten prüfbar** 15 %. Ab etwa 4 ist ein Thema Kandidat. Für die Reihenfolge zählen außerdem der Wettbewerb und die laufenden Reihen. Die Punktzahlen sind unsere Einschätzung **Vermutung** auf Basis von Recherche B.

Thema	Int.	Hype	Neu	Gef.	6 min	Score	Kern
Mikroplastik im Gehirn	4	5	5	2	4	**4,2**	„Ein Löffel Plastik“ gegen eine angefochtene Messmethode
Vitamin D: testen, Megadosen, Telomere	5	4	4	5	3	**4,3**	Leitlinie 2024 gegen 60.000-IE-Videos; passt zur angekündigten Mg-D-Folge
Kreatin fürs Gehirn	5	4	4	2	4	**4,0**	Stark umkämpft (8 deutsche Videos ≥ 200.000). Lohnt nur mit eigenem Winkel: „schlauer?“ (EFSA lehnt ab)
Kollagen für die Haut	4	5	4	2	5	**4,1**	Effekt verschwindet ohne Herstellergeld
Magnesium-L-Threonat	3	5	4	2	5	**3,9**	Drei Herstellerstudien. Fortsetzung der Mg-Reihe, die Zuschauer kennen die Reihe schon.
Zeitlich begrenztes Essen 16:8	4	4	5	2	3	**3,8**	Zwei Hypes gleichzeitig: Wundermittel und „91 % mehr Herztod“
Ashwagandha	3	4	4	4	5	**3,9**	BfR-Warnung, die in Supplement-Videos fehlt
„Natürliches Ozempic“ Berberin	4	5	3	4	4	**4,1**	−0,9 kg gegen ≈ −15 % unter Semaglutid

Fahrplan (Vorschlag)

1. **Vitamin D** mit Telomeren, Testen und Megadosen. Höchster Score und der Handlungstipp schützt vor echtem Schaden.
2. **Mikroplastik im Gehirn** als Lehrstück „erst die Messmethode prüfen“. Erster Einsatz der „Neu“-Szene.
3. **Kollagen**, das Schaufenster für die Regel „Herstellerstudien getrennt betrachten“.
4. **Berberin** mit ⚠-Szene zum Teilen von Spritzen und Absetzen von Therapien.
5. **Magnesium-Threonat** als dritter Teil der Mg-Reihe, erster blauer Marker mit Wiedervorlage.

Themenradar, wöchentlich 30 Minuten: Science Media Center (Feed), Medizin-transparent, BfR-Meldungen, Google Trends (Region DE) und die YouTube-Suche mit dem Filter „Dieses Jahr“, sortiert nach Aufrufen. Vor jedem Skript laufen die DOIs durch die Retraction-Watch-Datenbank. Hinweis: Das arznei-telegramm wird Ende 2026 eingestellt **Wahrscheinlich**.

9 · Was ich von dir brauche

1. **Impressum:** Gibt es eines, und wer ist Verantwortlicher nach § 18 Abs. 2 MStV?
2. **Vierte Stufe:** Soll „Frühe Hinweise“ in Blau so kommen? Dann passe ich Legende, Marker-Werte (ev) und `CLAUDE.md` an.
3. **Abschlusssatz:** A, B oder C? Ich empfehle B als Standard und C in der Szene.
4. **Fahrplan:** Vitamin D als nächstes Thema?
5. **Stimme:** Bisher hast du Christian mit gut bewertet, Marko und Marcus mit mittel, Alexander mit nein. Leo fehlt noch. Die Wertung lief nicht blind. Wenn Christian bleiben soll, gerne noch einmal im Blindmodus bestätigen, dann ist die Entscheidung belastbar.

Quellen (Auswahl, Details in recherche_A.md und recherche_B.md)

1. YouTube-Hilfe: Richtlinie zu medizinischen Fehlinformationen (support.google.com/youtube/answer/13813322); YPP „nicht authentische Inhalte“ (answer/1311392, Änderung 15.07.2025); veränderte oder synthetische Inhalte (answer/14328491); Intro-Bindung (answer/9314415); Mid-Roll ab 8 min (answer/6175006).
2. § 4 Abs. 3, 5 und § 10 HWG, aktueller Wortlaut: https://lxgesetze.de/hwg/4 · Pharmazeutische Zeitung zum neuen Pflichttext.
3. BGH, Urteil vom 26.03.2026, I ZR 74/25 (Werbung für medizinisches Cannabis): https://www.vzbv.de/urteile/zur-zulaessigkeit-von-werbung-fuer-medizinisches-cannabis
4. OLG Köln, Urteil vom 11.09.2025, 6 U 118/24 (Reel als audiovisuelles Medium, Influencerin als bekannte Person): https://www.beck-aktuell.de/heute-im-recht/rechtsprechung/olg-koeln-6u11824-werbung-arzneimittel-influencerin-heilmittelwerbegesetz-2025-10-24
5. EuGH, Urteil vom 02.04.2009, C-421/07 (Damgaard).
6. Medienanstalten: Merkblatt „Journalistische Sorgfalt in Online-Medien“; § 18, § 19 MStV; § 5 DDG.
7. Santesso N et al. GRADE guidelines 26. J Clin Epidemiol 2020. doi:10.1016/j.jclinepi.2019.10.014
8. Akl EA et al. Cochrane Database Syst Rev 2011, CD006776. doi:10.1002/14651858.CD006776.pub2
9. Pighin S et al. Med Decis Making 2011. doi:10.1177/0272989X10369000
10. Harding-Zentrum für Risikokompetenz: Methodenpapier Faktenboxen v2.2 (2021).
11. Medizin-transparent: Bewertungskriterien (medizin-transparent.at/bewertungs-kriterien).
12. IQWiG, gesundheitsinformation.de: „So arbeiten wir“.
13. Kang et al. JAMA Netw Open 2026; Kang et al. npj Digit Med 2026 (Clickbait und Glaubwürdigkeit); Toff & Simon, Int J Press/Politics 2024 (KI-Label und Quellenliste).

Offen: Teil 2 von Recherche A (Vorbildkanäle, Hooks, Abschlussformeln) lag beim Erstellen noch nicht vor. Sobald er kommt, ergänze ich Abschnitt 3 bei Bedarf.